# Compromiso de confidencialidad



## IDENTIFICACIÓN, OBJETIVO Y APLICABILIDAD

Procedimiento o manual de operación: Compromiso de confidencialidad. Su finalidad es establecer trazabilidad, responsabilidades y evidencia verificable para la atención segura y la autoevaluación del consultorio.

**Aplicabilidad: VERIFICAR EN LA AUTOEVALUACIÓN POR SERVICIO Y MODALIDAD.**

Ámbito de uso: atención ambulatoria e infraestructura autorizada en el REPS; adaptar el contenido a las condiciones, recursos, modalidad y cartera de servicios efectivamente declarados.

## RESPONSABILIDADES DIFERENCIADAS

01. Responsable técnico: médico/a competente designado/a, sin nombre preimpreso.
02. Apoyo administrativo: custodiar la versión controlada y facilitar registros completos.
03. Prestador: disponer de evidencias reales, gestionar correcciones y verificar habilitación.
04. Usuarios: recibir información suficiente, participar en decisiones y reportar alertas.

## RIESGOS PRIORITARIOS DE CONTROL

01. Acceso no autorizado: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
02. Pérdida de integridad: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
03. Divulgación no consentida: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
04. Registro clínico incompleto: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.

## REFERENTES NORMATIVOS PRINCIPALES

01. Decreto 780 de 2016 (SOGCS y régimen sectorial).
02. Resolución 3100 de 2019 y modificaciones aplicables (habilitación; manual anexo).
03. Resolución 2080 de 2026 (revocó la Resolución 1732 de 2026).
04. Ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015 (datos personales y sensibles).
05. Ley 2015 de 2020 (historia clínica electrónica interoperable, cuando aplique).

# Compromiso de confidencialidad



## SECUENCIA DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO

APERTURA | Verificar que la versión esté vigente, que la actividad pertenezca al alcance autorizado y que el responsable tenga competencia documentada.

IDENTIFICACIÓN | Corroborar sede, usuario o equipo según corresponda; definir fecha, turno, servicio y código del registro.

VALORACIÓN | Identificar riesgos, barreras de seguridad, contraindicación o hallazgo que exige suspender o remitir.

EJECUCIÓN | Aplicar el procedimiento escrito, las instrucciones del fabricante si son pertinentes y los controles específicos de este documento.

CIERRE | Registrar el resultado objetivo, informar hallazgos, entregar recomendaciones y activar seguimiento en caso necesario.

MEJORA | Ante desviación, abrir acción correctiva, responsable, fecha de cierre y evaluación posterior de eficacia.

## VERIFICACIONES ESPECÍFICAS PARA ESTA ACTIVIDAD

01. Separar autorización para tratamiento asistencial de autorización opcional para publicidad o redes.
02. Limitar acceso por roles, usar mecanismos seguros y prohibir fotografías en teléfonos personales no autorizados.
03. Controlar solicitudes, entrega a terceros, reclamos y revocatorias dentro de los límites legales.
04. Registrar incidente de privacidad y respuesta, preservando confidencialidad y trazabilidad.
05. Validar paciente e integridad cronológica del registro sin espacios modificables sin traza.
06. Restringir acceso según funciones y justificación clínica o legal.
07. Implementar reserva, respaldo, recuperación y respuesta ante pérdida o acceso indebido.

## CRITERIOS DE SUSPENSIÓN Y ESCALAMIENTO

Detener la actividad ante ausencia de competencia o autorización, condiciones inseguras, producto o equipo no conforme, negativa del paciente o signos clínicos de gravedad. Documentar la decisión y activar referencia cuando se necesite.

## INDICADORES DE CONTROL SUGERIDOS

Cumplimiento documental = registros completos / registros revisados x 100. Incidentes por actividad = incidentes notificados / actividades realizadas x 100. Ajustar metas a línea base y análisis de riesgo.

# Compromiso de confidencialidad



## CONTROL OPERATIVO PARA DILIGENCIAR

Sede / consultorio:

Responsable de ejecución (sin prellenar):

Fecha de diligenciamiento y código del caso / equipo:

Actividad verificada, hallazgo y resultado:

## LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTADA

| Verificación | Sí | No | NA | Observación / soporte |
|---|---|---|---|---|
| Separar autorización para tratamien | [ ] | [ ] | [ ] | _____ |
| Limitar acceso por roles, usar meca | [ ] | [ ] | [ ] | _____ |
| Controlar solicitudes, entrega a te | [ ] | [ ] | [ ] | _____ |
| Registrar incidente de privacidad y | [ ] | [ ] | [ ] | _____ |
| Validar paciente e integridad crono | [ ] | [ ] | [ ] | _____ |

## HALLAZGOS Y GESTIÓN DE MEJORAS

Hallazgo / desviación identificada:

Acción, responsable y plazo acordado:

Evidencia de cierre / verificación de eficacia:

## CONTROL DE VALIDACIÓN INSTITUCIONAL

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

Fecha: _____ Versión: _____ Próxima revisión: _____

Firma del profesional responsable: _____